¿Estatina con ezetimiba desde el inicio? Llega antes a la meta de LDL, pero no demostró menos eventos

Lee SH, Byun YS, Kim JW, Park JH, Cho JM, Kang WC, et al.; Ez-PAVE investigators. Statin–ezetimibe combination therapy versus statin monotherapy in atherosclerotic cardiovascular disease: a prespecified secondary analysis of the randomized Ez-PAVE trial. *Circulation*. 2026;154. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.126.083811

Versión 1.0 · Revisado el 12 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

PREGUNTA

¿Importa con qué se empieza?

En enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA), con meta de LDL y ajuste por protocolo, ¿iniciar con estatina + ezetimiba reduce eventos frente a estatina sola?

RESPUESTA

Eventos similares, LDL más bajo

Desenlace primario 8.5 frente a 7.9 % (HR 1.07; IC 95 % 0.83 a 1.37). Más pacientes en meta con la combinación, sin más efectos adversos. Análisis sin poder para eventos.

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Refuerza y matiza

Refuerza tratar hacia una meta y titular a tiempo. La combinación inicial es la vía más directa a <55 mg/dL, pero no demostró menos eventos que añadir ezetimiba cuando hace falta.

En 30 segundos. Ez-PAVE (17 centros de Corea del Sur, 3048 pacientes con ECVA) aleatorizó primero a una meta de LDL **<55 o <70 mg/dL** y, dentro de cada meta, a **iniciar con rosuvastatina–ezetimiba** (n = 1525) o con **estatina sola** (n = 1523); en ambos brazos se ajustaba el tratamiento por protocolo hasta la meta. El resultado primario del ensayo (meta <55 mejor que <70) ya se publicó; este es el **análisis secundario preespecificado** de la segunda aleatorización. A 3 años, el compuesto (muerte CV, IAM o EVC no fatales, revascularización u hospitalización por angina inestable) fue **8.5 % con la combinación y 7.9 % con monoterapia** (HR 1.07; IC 95 % 0.83 a 1.37). La combinación logró un LDL mediano más bajo (58 frente a 66 mg/dL) y más pacientes en meta (con meta <55: **69.4 frente a 52.2 %** a 3 años), aunque a 29.6 % de los de monoterapia se les añadió ezetimiba. El beneficio de la meta intensiva no dependió del régimen inicial (p de interacción = 0.583). Seguridad comparable.

1 Diseño y población (PICO)

P · POBLACIÓN	Adultos con ECVA documentada (SCA previo, angina estable confirmada, revascularización arterial, EVC o isquemia cerebral transitoria [AIT], o enfermedad arterial periférica); se excluyó LDL <70 mg/dL sin estatina. Edad media 64.4 años; 20.9 % mujeres; diabetes 39.6 % (40.9 y 38.3 % por brazo); LDL basal mediano 76 mg/dL (RIC 61 a 96); ~9 de cada 10 ya tomaban estatina, sobre todo de intensidad moderada.
I · INTERVENCIÓN	Iniciar con la combinación rosuvastatina–ezetimiba.
C · COMPARACIÓN	Iniciar con estatina sola (a su vez aleatorizada a rosuvastatina o atorvastatina). Dosis inicial a criterio del investigador según el tratamiento previo, el LDL y la meta. En ambos brazos, si no se llegaba a la meta: subir la estatina o añadir ezetimiba antes de un inhibidor de PCSK9.
O · DESENLACES	Primario: compuesto a 3 años de muerte CV, IAM no fatal, EVC no fatal, cualquier revascularización u hospitalización por angina inestable. Secundarios: componentes y otros compuestos. Seguridad: diabetes nueva, empeoramiento glucémico, síntomas musculares, cáncer, cirugía de catarata y laboratorio.
DISEÑO	Multicéntrico, abierto, iniciado por los investigadores, con adjudicación ciega de eventos; todas las aleatorizaciones al ingreso. Controles al mes y a 1, 2 y 3 años. Análisis por intención de tratar (Cox sin ajustar), por protocolo y de riesgos competitivos. **La muestra se calculó para comparar las metas, no los regímenes iniciales.**
FINANCIAMIENTO	Cardiovascular Research Center y Yuhan; según los autores, los financiadores no intervinieron en el diseño, el análisis ni la redacción. Varios autores declaran pagos de la industria. Registro NCT04626973.

CONCEPTO CLAVE · ¿QUÉ ES UN «ANÁLISIS SECUNDARIO PREESPECIFICADO»?

DATO DEL ARTÍCULO Ez-PAVE tenía una **pregunta principal**: ¿una meta de LDL <55 mg/dL es mejor que <70? Esa comparación definió el tamaño de muestra y ya se publicó (la meta intensiva redujo eventos sin más efectos adversos). La comparación «combinación inicial frente a monoterapia inicial» venía escrita en el protocolo y en el plan de análisis publicados antes, y también se aleatorizó; pero los autores aclaran que **no tiene poder** para detectar diferencias modestas en eventos y la califican de generadora de hipótesis. **INTERPRETACIÓN** «Preespecificado» protege contra la búsqueda de resultados a posteriori, y «aleatorizado» hace que los grupos sean comparables (la tabla 1 lo confirma). Ninguna de las dos cosas da poder estadístico. El

resultado primario del ensayo puede cambiar la práctica; este análisis, por sí solo, responde con mucha menos precisión. Es, en la práctica, un factorial 2 × 2: cada paciente aporta a las dos preguntas.

2 Resultados principales

DESENLACE A 3 AÑOS (ITT)	COMBINACIÓN (N = 1525)	MONOTERAPIA (N = 1523)	DIFERENCIA, PUNTOS	HR (IC 95 %)
Primario (compuesto de 5 componentes)	**128 (8.5 %)**	**119 (7.9 %)**	**0.6 (−1.4 a 2.5)**	**1.07 (0.83–1.37)**
· En la estrategia con meta <55	54/763 (7.1 %)	46/763 (6.1 %)	—	1.17 (0.79–1.73)
· En la estrategia con meta <70	74/762 (9.8 %)	73/760 (9.7 %)	—	1.01 (0.73–1.40)
Muerte cardiovascular	18 (1.2 %)	15 (1.0 %)	0.2 (−0.5 a 0.9)	1.20 (0.60–2.37)
IAM no fatal	21 (1.4 %)	17 (1.1 %)	0.3 (−0.5 a 1.1)	1.23 (0.65–2.33)
EVC no fatal	8 (0.5 %)	10 (0.7 %)	−0.1 (−0.7 a 0.4)	0.80 (0.31–2.02)
Cualquier revascularización	100 (6.6 %)	85 (5.7 %)	1.0 (−0.7 a 2.7)	1.17 (0.88–1.57)
Hospitalización por angina inestable	28 (1.9 %)	30 (2.0 %)	−0.1 (−1.1 a 0.8)	0.93 (0.55–1.55)
Muerte CV, IAM o EVC no fatales	47 (3.1 %)	41 (2.7 %)	0.4 (−0.8 a 1.6)	1.14 (0.75–1.74)

Porcentajes = incidencia acumulada de Kaplan-Meier. Diferencia = combinación menos monoterapia (IC 95 %). Los análisis por protocolo y de riesgos competitivos fueron consistentes.

LDL Y TRATAMIENTO RECIBIDO	COMBINACIÓN INICIAL	MONOTERAPIA INICIAL
LDL mediano en el seguimiento (global)	58 mg/dL (RIC 49 a 68)	66 mg/dL (RIC 58 a 77)
· Meta <55 · meta <70	53 (45 a 62) · 63 (55 a 73)	62 (53 a 74) · 70 (62 a 81)
En meta, estrategia <55 (1 mes → 3 años)	44.3 → 69.4 %	18.3 → 52.2 %
En meta, estrategia <70 (1 mes → 3 años)	71.6 → 73.2 %	47.1 → 63.1 %
Con ezetimiba (1 mes → 3 años)	98.6 → 93.8 %	1.0 → 29.6 % (34.3 % con meta <55; 24.8 % con meta <70)
Con estatina de alta intensidad (1 mes → 3 años)	26.1 → 26.6 %	63.4 → 54.0 %

Todas las diferencias de LDL y de logro de metas, p <0.001. Seguimiento mediano de 3.0 años.

3 La gráfica: más pacientes en meta, eventos similares

Pacientes con LDL <55 mg/dL (estrategia intensiva)



Desenlace primario a 3 años: HR (IC 95 %)

Combinación frente a monoterapia (eventos, %)

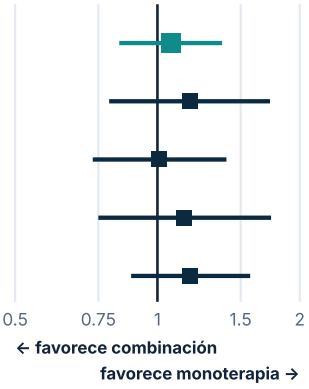
Global
8.5 frente a 7.9 % · 1.07 (0.83–1.37)

Meta <55 mg/dL
7.1 frente a 6.1 % · 1.17 (0.79–1.73)

Meta <70 mg/dL
9.8 frente a 9.7 % · 1.01 (0.73–1.40)

Muerte CV, IAM o EVC
3.1 frente a 2.7 % · 1.14 (0.75–1.74)

Revascularización
6.6 frente a 5.7 % · 1.17 (0.88–1.57)



Interacción con la meta de LDL: p = 0.583

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto de Resultados y de la tabla 2 del artículo (escala logarítmica en el panel derecho). No reproduce figuras originales.

4 Seguridad

DESENLACE DE SEGURIDAD	COMBINACIÓN	MONOTERAPIA	RAZÓN DE MOMIOS, RM (IC 95 %)
Diabetes de nueva aparición (sin DM basal)	154/901 (17.1 %)	147/940 (15.6 %)	1.11 (0.87–1.42)
Empeoramiento glucémico (con DM basal)	321/624 (51.4 %)	279/583 (47.9 %)	1.15 (0.92–1.45)
Síntomas musculares asociados a estatina	10 (0.7 %)	14 (0.9 %)	0.71 (0.31–1.60)
Diagnóstico de cáncer	43 (2.8 %)	33 (2.2 %)	1.31 (0.83–2.09)
Cirugía de catarata	17 (1.1 %)	19 (1.2 %)	0.89 (0.46–1.73)
Transaminasas ≥3 × LSN · creatinina >1.5 × basal · CK >4 × LSN	2.3 · 1.8 · 0.2 %	1.6 · 2.1 · 0.3 %	1.41 · 0.84 · 0.60 (todas p >0.19)

DATO DEL ARTÍCULO Ninguna diferencia significativa ni señales inesperadas; consistente por protocolo. **INTERPRETACIÓN** Un LDL más bajo con estatina menos potente más ezetimiba no añadió efectos adversos en 3 años, pero los IC anchos (cáncer: 0.83 a 2.09) no descartan diferencias pequeñas.

5 Fortalezas y limitaciones: cómo leer el resultado

- **«Sin diferencia significativa» no es «equivalentes».** **DATO DEL ARTÍCULO** HR 1.07 (IC 95 % 0.83 a 1.37); diferencia absoluta 0.6 puntos (–1.4 a 2.5); sin poder para diferencias modestas. **INTERPRETACIÓN** El IC es compatible con 17 % menos o 37 % más riesgo con la combinación inicial. No hay señal de beneficio ni de daño, pero demostrar que «da igual» exigiría un diseño de no inferioridad con margen predefinido.
- **Se compararon estrategias, no «ezetimiba frente a nada».** **DATO DEL ARTÍCULO** A 3 años, 29.6 % del brazo de monoterapia recibía ezetimiba y ese brazo usó más estatina de alta intensidad (54.0 frente a 26.6 %); el LDL mediano fue 58 frente a 66 mg/dL. **INTERPRETACIÓN** Por intención de tratar, la pregunta fue «¿empezar con la combinación o añadir ezetimiba si no se llega a la meta?». Si los brazos convergen, la diferencia de eventos esperable se achica; los autores añaden que la estatina más potente pudo compensar el LDL algo más alto.
- **La combinación cambia la velocidad y la probabilidad de llegar a la meta.** **DATO DEL ARTÍCULO** Con meta <55: 44.3 frente a 18.3 % en meta al mes; 69.4 frente a 52.2 % a 3 años. Aun así, a 3 años no llegaron a <55 el 30.6 % con combinación y el 47.8 % con monoterapia (y 22.0 % del brazo de monoterapia ni siquiera bajó de 70); el inhibidor de PCSK9 casi no se usó (1.3 a 1.8 %). **INTERPRETACIÓN** Aun con protocolo de titulación, la inercia fue grande; en la consulta real, la ventaja de empezar con dos fármacos probablemente pesa más.
- **El efecto de la meta fue el mismo con cualquier inicio.** **DATO DEL ARTÍCULO** La meta intensiva pareció reducir el desenlace primario en ambos brazos: p = 0.060 con la combinación y p = 0.011 con la monoterapia; interacción p = 0.583. **INTERPRETACIÓN** Una p significativa en un subgrupo y otra no en el otro no demuestran un efecto distinto; eso lo dice la interacción, y no la hubo. La meta importa más que el fármaco inicial.
- **El subgrupo con EVC o AIT previo: hipótesis, no conclusión.** **DATO DEL ARTÍCULO** Fue el único subgrupo con interacción significativa (p = 0.029), con más eventos con la combinación inicial; exploratorio según los autores; según la tabla 1, solo 117 pacientes (65 + 52) tenían ese antecedente como criterio de ingreso. **INTERPRETACIÓN** Con muchos subgrupos, uno «significativo» puede aparecer por azar, y el grupo es pequeño. No basta para evitar la ezetimiba en estos pacientes.

● **Fortalezas** **DATO DEL ARTÍCULO** Comparación aleatorizada y preespecificada, grupos balanceados, adjudicación ciega; resultados consistentes por protocolo, con riesgos competitivos y en casi todos los subgrupos. ● **Otras limitaciones** **DATO DEL ARTÍCULO** Diseño abierto (pudo influir en cuándo se ajustaba el tratamiento); no se puede excluir la influencia del control de la presión arterial y la glucemia; solo pacientes de Asia oriental, 79 % hombres; sin análisis de costo-efectividad. **INTERPRETACIÓN** El compuesto lo dominan las revascularizaciones (100 y 85 eventos).

6 Cómo encaja con la evidencia previa y las guías

- **IMPROVE-IT.** **DATO DEL ARTÍCULO** Mostró que añadir ezetimiba a la estatina tras un síndrome coronario agudo mejora los desenlaces, pero con un régimen fijo, sin ajuste hacia una meta y antes de que se recomendara <55 mg/dL. **INTERPRETACIÓN** IMPROVE-IT respondió «¿ezetimiba sí o no?» con régimen fijo; Ez-PAVE, «¿desde cuándo?» dentro de un esquema de metas. No se contradicen: aquí ambos brazos podían recibir ezetimiba.
- **RACING.** **DATO DEL ARTÍCULO** Estatina de intensidad moderada con ezetimiba frente a estatina de alta intensidad: resultados clínicos comparables pese a un LDL más alto en el brazo de monoterapia, y menos efectos adversos relacionados con la estatina con la combinación. Los autores ven el mismo patrón en Ez-PAVE.
- **Guías.** **DATO DEL ARTÍCULO** Las guías han bajado las metas de LDL en la ECVA y piden intensificar si no se alcanzan (la ESC/EAS 2019 y su actualización de 2025 recomiendan <55 mg/dL); después, el resultado primario de Ez-PAVE aportó evidencia aleatorizada directa a favor de esa meta. **INTERPRETACIÓN** Este análisis no cambia la meta: aporta una vía más eficiente para alcanzarla.

7 Qué hacer en la consulta

- INTERPRETACIÓN **Primero la meta (<55 mg/dL en ECVA), luego el fármaco.** Si el LDL está lejos, iniciar con la combinación es razonable: llega antes a la meta, sin más efectos adversos, aunque no demostró menos infartos.
- INTERPRETACIÓN **Si empiezas con estatina sola, titula sin demora:** repite el LDL pronto (el ensayo midió al mes); el riesgo de esta vía es la inercia.
- INTERPRETACIÓN **Si la estatina de alta intensidad no se tolera o no se acepta**, la de intensidad moderada con ezetimiba tiene respaldo en RACING y en este análisis. Sin meta con dos fármacos, el protocolo seguía con un inhibidor de PCSK9.

Lección de lectura crítica

- **Preespecificado y aleatorizado no es lo mismo que con poder:** la muestra se calculó para comparar metas; el IC de 0.83 a 1.37 no permite hablar de equivalencia.
- **Intención de tratar con brazos que convergen:** con 29.6 % de ezetimiba en el brazo de monoterapia, se compararon estrategias, no fármacos.
- **Interacción, no p de subgrupos:** p = 0.060 frente a 0.011 no es diferencia; la interacción fue p = 0.583.

Qué me llevo

- En ECVA, tratar hacia una meta es lo que pesa; <55 mg/dL ya tiene respaldo aleatorizado.
- Iniciar con estatina + ezetimiba más que duplica la proporción de pacientes en meta <55 al primer mes (44.3 frente a 18.3 %) y la mantiene más alta a 3 años, sin más efectos adversos.
- Empezar con estatina sola y titular a tiempo dio eventos similares en 3 años, sin poder para descartar diferencias.

PON A PRUEBA LO APRENDIDO

1. Hombre de 58 años, IAM hace 2 meses, con estatina de intensidad moderada y LDL de 98 mg/dL. Un residente no quiere añadir ezetimiba «porque Ez-PAVE demostró que no reduce eventos». ¿Qué es lo correcto?
a) Tiene razón: el análisis demostró equivalencia. · b) La combinación aumentó los eventos (HR 1.07). · c) El análisis no tenía poder para eventos, comparó estrategias que convergían y con la combinación más pacientes alcanzaron la meta; lo prioritario es llevarlo a la meta. · d) Ez-PAVE solo aplica a la meta <70.
Respuesta: c. El IC 0.83 a 1.37 no permite afirmar equivalencia (a) ni daño (b), y el análisis abarcó ambas metas (d). Con LDL de 98, la meta (<55) está lejos: hay que intensificar, con ezetimiba o con más estatina.

2. Mujer de 66 años con EVC isquémico previo y LDL de 85 mg/dL con estatina. Un colega dice que en Ez-PAVE la ezetimiba «fue dañina en EVC». ¿Cómo lees ese dato?
a) Es un hallazgo firme: evita la ezetimiba en EVC. · b) Es un subgrupo exploratorio (interacción p = 0.029; ≈117 pacientes): genera hipótesis, no cambia la práctica. · c) Demuestra que en EVC la meta debe ser <70. · d) La ezetimiba aumenta el EVC no fatal en todos.
Respuesta: b. Los autores lo llaman exploratorio. El EVC no fatal global fue 0.5 frente a 0.7 % (HR 0.80; IC 0.31 a 2.02), así que (d) es falso. El análisis no comparó metas en EVC (c).

3. En la sesión alguien concluye: «la meta <55 solo sirve si usas estatina sola, porque con la combinación la p fue 0.060 y con monoterapia 0.011». ¿Qué respondes?
a) Correcto: usa monoterapia para que la meta funcione. · b) Error: comparar p de subgrupos no demuestra un efecto distinto; la interacción (p = 0.583) no mostró diferencia. · c) Correcto, porque con la combinación el LDL ya era bajo. · d) No se puede saber: la meta no se aleatorizó.
Respuesta: b. La meta sí se aleatorizó (d es falso). Si un efecto cambia entre subgrupos lo dice la interacción (p = 0.583).

8 Referencias

1. Lee SH, Byun YS, Kim JW, et al. Statin–ezetimibe combination therapy versus statin monotherapy in atherosclerotic cardiovascular disease: a prespecified secondary analysis of the randomized Ez-PAVE trial. Circulation. 2026;154. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.126.083811
2. Lee YJ, Lee SJ, Kim JW, et al.; Ez-PAVE Investigators. Intensive LDL cholesterol targeting in atherosclerotic cardiovascular disease. N Engl J Med. 2026;394:1365–1375. doi:10.1056/NEJMoa2600283
3. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al.; IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015;372:2387–2397. doi:10.1056/NEJMoa1410489
4. Kim BK, Hong SJ, Lee YJ, et al.; RACING investigators. Long-term efficacy and safety of moderate-intensity statin with ezetimibe combination therapy versus high-intensity statin monotherapy in patients with atherosclerotic cardiovascular disease (RACING): a randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2022;400:380–390. doi:10.1016/S0140-6736(22)00916-3
5. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41:111–188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455
6. Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, et al. 2025 Focused update of the 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2025;46:4359–4378. doi:10.1093/eurheartj/ehaf190

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.